

1 vez al día

Zebinix®

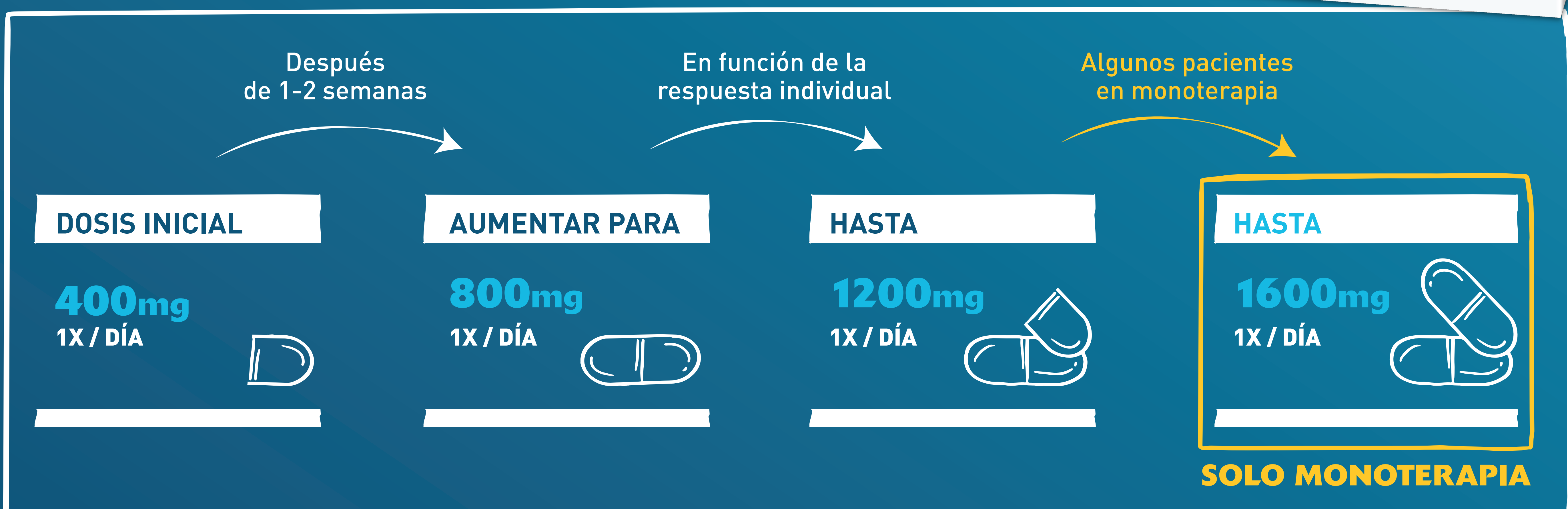
acetato de eslicarbazepina

AHORA INDICADO
EN MONOTERAPIA!¹

Simplifica la vida.

- Eficacia a largo plazo.²
- Buen perfil de tolerabilidad.³
- Posología fácil y simple, una vez al día, con elevada tasa de adherencia al tratamiento^{1,4}

Posología y Titulación Simples¹



ZEBINIX ES FÁCIL DE USAR¹

UNA VEZ AL DÍA
1x 24h

COMPRIMIDOS ENTEROS O TRITURADOS

CON O SIN ALIMENTOS



1. Zebinix® Resumen de las Características del Producto. 2. Halász P, Cramer JA, Hodoba D, et al. Long-term efficacy and safety of eslicarbazepine acetate: results of a 1-year open-label extension study in partial-onset seizures in adults with epilepsy. *Epilepsia*. 2010;51(10):1963-1969. 3. Trinka E, et al. Efficacy and safety of eslicarbazepine acetate versus controlled-release carbamazepine monotherapy in newly diagnosed epilepsy: A phase III double-blind, randomized, parallel-group, multicenter study. *Epilepsia*. 2018;59(2):479-91. 4. Villanueva V, et al. Euro-Esli: a European audit of real-world use of eslicarbazepine acetate as a treatment for partial-onset seizures. *J Neurol*. 2017;264(11):2232-2248.

Zebinix® 800 mg, comprimidos contiene 800 mg de acetato de eslicarbazepina. Forma farmacéutica: Comprimido. Comprimidos oblongos, con una longitud de 19 mm, de color blanco, con la leyenda "ESL 800" grabada en una de las caras, y ranurados en la otra. El comprimido se puede dividir en dosis iguales. **Indicaciones terapéuticas:** Zebinix® 800 mg está indicado en: monoterapia para el tratamiento de crisis de inicio parcial, con o sin generalización secundaria, en adultos con epilepsia recién diagnosticada; como terapia adyuvante en pacientes adultos, adolescentes y niños mayores de 6 años, con crisis de inicio parcial, con o sin generalización secundaria. **Posología y forma de administración Adultos:** Zebinix® 800 mg se puede tomar en monoterapia o añadirse al tratamiento anticonvulsivo existente. La dosis inicial recomendada es de 400 mg una vez por día y deberá aumentarse a 800 mg una vez por día después de una o dos semanas de tratamiento. En función de la respuesta individual, la dosis puede incrementarse a 1200 mg una vez al día. Algunos pacientes en monoterapia se pueden beneficiar de una dosis de 1.600 mg una vez al día. Forma de administración: Vía oral. Zebinix® puede administrarse con o sin alimentos. Los pacientes que no puedan tragar los comprimidos enteros, pueden triturarlos y mezclarlos con agua o comidas blandas, como compota de manzana, inmediatamente antes de su uso para la administración oral. **Contraindicaciones:** Hipersensibilidad al principio activo, a otros derivados de carboxamida (por ejemplo carbamazepina, oxcarbazepina), o a alguno de los excipientes. Bloqueo aurículoventricular (AV) de segundo o tercer grado conocido. **Advertencia:** Deben tomarse las precauciones pertinentes en el tratamiento de pacientes con insuficiencia renal, y debe ajustarse la dosis según los valores de aclaramiento de creatinina. No se recomienda el uso en pacientes con CL_{CR} <30 ml/min debido a la escasez de datos. Dado que los datos clínicos son limitados en pacientes con insuficiencia hepática leve a moderada, y que se carece de datos clínicos en pacientes con insuficiencia hepática grave, el acetato de eslicarbazepina debe utilizarse con precaución en pacientes con insuficiencia hepática leve a moderada, y no se recomienda su uso en pacientes con insuficiencia hepática grave. **Interacción con otros medicamentos:** La eslicarbazepina in vivo mostró un efecto inductor sobre el metabolismo de los medicamentos que se eliminan principalmente a través del metabolismo del CYP3A4. Un estudio en sujetos sanos demostró un descenso promedio del 50% en la exposición sistémica a la simvastatina cuando se administraba conjuntamente con 800 mg de acetato de eslicarbazepina una vez al día, provocado muy probablemente por una inducción del CYP3A4. Puede ser necesario aumentar la dosis de simvastatina cuando ésta se utilice de forma concomitante con acetato de eslicarbazepina. Hubo una reducción media del 36-39% en la exposición sistémica en voluntarios sanos cuando se coadministró con acetato de eslicarbazepina 1.200 mg una vez al día. El mecanismo de esta reducción es desconocido pero podría ser debido a la interferencia en el transporte de la rosuvastatina aislada o en combinación con la inducción de su metabolismo. Dado que la relación entre la exposición y la actividad del fármaco no está clara, se recomienda la monitorización de la respuesta al tratamiento (p. ej. niveles de colesterol). La administración de 1200 mg de acetato de eslicarbazepina una vez al día a mujeres que usaban un anticonceptivo oral combinado mostró una disminución promedio del 37% y 42% en la exposición sistémica al levonorgestrel y al etillevonorgestrel, respectivamente, provocada más probablemente por una inducción de la enzima CYP3A4. Por lo tanto, las mujeres en edad fértil deberán utilizar un método anticonceptivo adecuado durante el tratamiento con Zebinix, y hasta el final del ciclo menstrual en curso tras la interrupción del tratamiento. En un estudio en sujetos sanos, la administración concomitante de 800 mg de acetato de eslicarbazepina una vez al día y de 400 mg de carbamazepina dos veces al día dio lugar a una disminución promedio del 32% en la exposición al metabolito activo eslicarbazepina, provocada muy probablemente por una inducción de la glucuronidación. No se observó ningún cambio en la exposición a la carbamazepina ni a su metabolito, el epóxido de carbamazepina. En función de la respuesta individual, puede ser necesario aumentar la dosis de acetato de eslicarbazepina si se utiliza de forma concomitante con carbamazepina. **Efectos adversos o secundarios:** En ensayos clínicos (tratamiento como terapia adyuvante y monoterapia), fueron tratados con acetato de eslicarbazepina 2.434 pacientes con crisis de inicio parcial (1.983 pacientes adultos y 451 pacientes pediátricos) y el 51% de los pacientes experimentaron reacciones adversas. Las reacciones adversas fueron por lo general de intensidad leve a moderada, y se produjeron predominantemente durante las primeras semanas del tratamiento con acetato de eslicarbazepina. Los riesgos que se han identificado para Zebinix son principalmente reacciones adversas de clase, dosis dependiente. Las reacciones adversas más comunes, notificadas en los ensayos clínicos en terapia adyuvante controlados con placebo, en pacientes epilépticos adultos y en ensayos clínicos controlados con comparador activo en monoterapia, comparando acetato de eslicarbazepina con carbamazepina de liberación controlada, fueron mareo, somnolencia, cefalea y náuseas. La mayoría de las reacciones adversas fueron notificadas por <3% de los pacientes dentro de cualquier grupo de tratamiento. Fue utilizada la siguiente convención para clasificación de las reacciones adversas: muy frecuentes: ≥1/10, frecuentes: ≥1/100 a <1/10, poco frecuentes: ≥1/1.000 a <1/100, frecuencia no conocida (no puede estimarse a partir de los datos disponibles). Las reacciones adversas se enumeran en orden decreciente de gravedad dentro de cada intervalo de frecuencia: **Muy frecuentes:** mareo, somnolencia. **Frecuentes:** hiponatremia, disminución del apetito, insomnio, cefalea, alteración de la atención, temblores, ataxia, trastornos del equilibrio, hipocloremia, trastornos psicóticos, apatía, depresión, nerviosismo, agitación, irritabilidad, fatiga, alteración de la marcha, astenia, aumento de peso. **Poco frecuentes:** anemia, hipersensibilidad, hipotiroidismo, desequilibrio electrolítico, deshidratación, hipocloremia, trastornos psicóticos, apatía, depresión, nerviosismo, agitación, irritabilidad, trastorno de hiperactividad / déficit de atención, estado confusional, cambios de estado de ánimo, llanto, retraso psicomotor, ansiedad, coordinación anormal, deterioro de la memoria, amnesia, hipersomnia, sedación, afasia, disestesia, distonía, letargia, parosmia, síndrome cerebeloso, convulsión, neuropatía periférica, nistagmo, trastornos del habla, disartria, sensación de ardor, parestesia, migraña, deficiencia visual, oscilopsia, trastorno del movimiento binocular, hiperemia ocular, hipocausia, acúfenos, palpitaciones, bradicardia, hipertensión (incluyendo crisis hipertensivas), hipotensión, hipotensión ortostática, rubor, enfriamiento periférico, epistaxis, dolor torácico, estreñimiento, dispepsia, gastritis, dolor abdominal, boca seca, molestias abdominales, distensión abdominal, gingivitis, melena, dolor en los dientes, trastornos hepáticos, alopecia, piel seca, hiperhidrosis, eritema, dermatitis alérgica, mialgia, trastorno del metabolismo óseo, debilidad muscular, dolor en extremidades, infección de las vías urinarias, malestar, escalofríos, edema periférico, Presión arterial disminuida, peso disminuido, presión arterial aumentada, niveles de sodio disminuido en sangre, niveles de cloruro disminuidos en sangre, osteocalcina aumentada, hematocrito disminuido, niveles de hemoglobina disminuida, niveles de transaminasas elevadas, Toxicidad medicamentosa, caída, quemadura térmica. Frecuencia no conocida: Trombocitopenia, leucopenia, Pancreatitis, Necrólisis epidérmica tóxica, síndrome de Stevens-Johnson, reacción al medicamento con eosinofilia y síntomas sistémicos (DRESS), angioedema, urticaria. **Fecha de revisión:** Marzo 2021 **Presentación:** ZEBINIX® 800 mg- 30 comp. **Medicamento sujeto a prescripción médica. Titular de la Autorización de Comercialización:** BIAL-Portela & C^a, S.A. - A Av. da Siderurgia Nacional • 4745-457 S. Mamede do Coronado - Portugal **Información complementaria más detallada bajo pedido. DMgMA_PT210728 Zebinix®: Registro en embarazo:** Para poder proporcionar información sobre los efectos en el útero debidos a la exposición de ZEBINIX®, se aconseja a los facultativos que inscriban en el registro internacional de fármacos antiepilépticos y embarazo (International Registry of Antiepileptic Drugs and Pregnancy, EURAP) a las pacientes embarazadas que tomen ZEBINIX®. Para más información: <http://www.eurapinternational.org/>. BIAL-Portela & C^a S.A. patrocina el EURAP Pregnancy Registry para ampliar el conocimiento científico sobre seguridad y resultados en mujeres embarazadas tratadas con fármacos antiepilépticos, incluyendo Acetato de Eslicarbazepina (ZEBINIX®), y para responder a un requerimiento del Comité de Medicamentos de Uso Humano (Committee for Medicinal Products for Human Use, CHMP) para hacer frente a la información que falta sobre la seguridad en el embarazo.